

MEDICAMENTS UTILISES

EN

GASTRO - ENTEROLOGIE

IFSI

2ème année IDE

10 AVRIL 2007

Sommaire

I - Les médicaments antiulcéreux et antiacides

II - Les antiémétiques

III - Les antidiarrhéiques

IV - Les laxatifs

V - Les extraits pancréatiques

VI - Les médicaments de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn

VII - Les antireflux

VIII - Les antihémorroïdaires

I - Les antiulcéreux et les antiacides

A - Les antisécrétoires gastriques – Antihistaminiques H2

Spécialités

Ranitidine **AZANTAC® RANIPLEX®**

Famotidine **PEPDINE®**

Cimétidine **TAGAMET®**

Présentation: Injectable, cp , gélule

Suffixe: TIDINE

Propriétés

Réduisent la sécrétion gastrique par blocage de récepteurs histaminiques de type H2

Contre-Indications

Hypersensibilité connue aux différents produits et phénylcétonurie (pour les cps effervescents)

Effets indésirables

Très rares

Céphalées, constipation ou diarrhées

Exceptionnels: éruptions cutanées, vertiges , syndromes confusionnels (personnes âgées, insuffisance rénale ou hépatique)

Très exceptionnel: leucopénie

Favorise le développement bactérien intragastrique

Grossesse et allaitement : utilisation déconseillée (innocuité non établie)

Précautions d'emploi

En cas d'ulcère vérifier le caractère bénin par biopsie

Pas d'arrêt brutal à forte dose

Diminuer la posologie en cas d'insuffisance rénale ou hépatique sévère

Interactions médicamenteuses

Topiques gastro-duodénaux: respecter un intervalle de 2h00

Exception: la Cimétidine : Nombreux car inhibiteurs enzymatiques : Béta bloqueurs, BZD, Théophylline et dérivés, ...

Indications

Ulcères duodénaux ou gastriques évolutifs

Prévention des récives d'ulcères gastro-duodénaux

Ulcère gastro duodénal lié au stress ou d'origine médicamenteuse

Oesophagite par reflux gastro-duodénal

Syndrome de Zollinger-Ellison

B - Les antisécrotoires gastriques – Inhibiteurs de la pompe à protons ou IPP

Spécialités

Oméprazole **MOPRAL° OMEPRAZOLE Ge°**

Esoméprazole **INEXIUM°**

Pantoprazole **EUPANTOL° INIPOMP°**

Présentation: Injectable, cp, gélule

Suffixe: PRAZOLE

Propriétés

Réduisent la sécrétion gastrique indépendamment du mode de stimulation, leur durée d'action prolongée (> 24h00) autorise 1 seule prise quotidienne et leur efficacité est supérieure à celle des autres antiulcéreux.

Contre-Indications

Hypersensibilité connue aux différents produits (très rare)

Allaitement (absence d'étude)

Effets indésirables

Assez rares

Troubles transitoires en début de traitement: nausées, vomissements et flatulences

Réactions cutanées: arrêt du traitement

Très exceptionnels: syndrome confusionnel, leucopénie, ...

Favorise le développement bactérien intragastrique

Précautions d'emploi

En cas d'ulcère vérifier le caractère bénin par biopsie

Pas d'arrêt brutal à forte dose

Insuffisance hépatique: ne pas dépasser les doses

Grossesse : innocuité non établie et passage transplacentaire

Enfant >1 an : AMM dans oesophagite avec reflux

Interactions médicamenteuses

Topiques gastro-duodénaux: respecter un intervalle de 2h00

Indications

Ulcères duodénaux ou gastriques évolutifs

Prévention des récurrences d'ulcères gastro-duodénaux

Ulcère gastro duodénal lié au stress ou d'origine médicamenteuse

Oesophagite par reflux gastro-duodénal résistant aux autres traitements

Syndrome de Zollinger-Ellison: traitement de référence

C - Les antisécrétoires gastriques – Prostaglandines antiulcéreuses

Spécialité

Misoprostol **CYTOTEC®**

Présentation: cp.sec.

Propriétés

Analogue de la prostaglandine E1 ayant un effet antisécrétoire légèrement moins puissant que les anti H2, effet cytoprotecteur

Contre-Indications

Hypersensibilité connue au produit

Femme en période d'activité génitale sans contraception efficace

Effets indésirables

Assez fréquents: diarrhée modérée et transitoire

Plus rares: nausées transitoires, douleurs abdominales

Réactions allergiques très rares

Favorise le développement bactérien intragastrique

Précautions d'emploi

En cas d'ulcère vérifier le caractère bénin par biopsie

Grossesse: contraception efficace car chez l'animal fréquence d'avortement spontanée augmentée

Interactions médicamenteuses

Kétoconazole

Topiques gastro-duodénaux: respecter un intervalle de 2h00

Indications

Ulcère duodénal ou gastrique évolutif induit ou non par les AINS (en curatif ou en préventif)

D - Les antiulcéreux - Topiques antiulcéreux

Spécialité

Sucralfate **KEAL®, ULCAR®, SUCRALFATE®**

Présentation: cp.sec., sachet

Propriétés

Sel complexe d'aluminium dépourvu d'activité sécrétoire ou antiacide, il forme une substance visqueuse et adhésive sur les protéines constituant les berges et l'exsudat de l'ulcère, il est ainsi isolé et donc cicatrise à l'abri de toute acidité.

Contre-Indications

Pas de CI Absolue

Effets indésirables

Rares

Constipation liée à l'aluminium

Bouche sèche, nausées, vomissements

Précautions d'emploi

- Prendre à distance des repas (30 minutes avant 2h00 après)
- En cas d'ulcère, vérifier le caractère bénin par biopsie
- Eviter chez l'insuffisant rénal chronique

Interactions médicamenteuses

- Prendre à distance des repas 2h00 après ou plus avec:
- AVK, digoxine, car diminution de la résorption digestive

Indications

- Ulcère duodénal et gastrique évolutif
- Prévention des récurrences d'ulcère gastro-duodénal

I

D - Les antiacides ou topiques antiacides

Spécialités

- Hydroxyde d'aluminium + Hydroxyde de magnésium **GELOX° XOLAAM°, MAALOX°**
- Phosphate d'aluminium **PHOSPHALUGEL°**
- Présentation: cp.sec., sachet, solution

Propriétés

- Antiacides de contact diminuent l'acidité de la sécrétion gastrique par effet tampon par neutralisation de HCl
- Moins efficace que les antiH2
- Action brève 30 à 60 min.

Contre-Indications

- Insuffisance rénale sévère allergie à un des constituants

Effets indésirables

- Aluminium: Encéphalopathie aluminique aux posologies élevées et chez insuffisants rénaux
- Hydroxyde d'aluminium: Risque de déplétion phosphorée
- Phosphate d'aluminium : Effet constipant
- Sels de magnésium: Effet laxatif par rétention d'eau

Précautions d'emploi

- Les aliments ont un pouvoir tampon, donc on doit les prendre 90 minutes après début de chaque repas et au coucher et au moment des douleurs
- En cas d'ulcère vérifier le caractère bénin par biopsie

Interactions médicamenteuses

- Très nombreuses
- Prendre à distance des repas 2h00 après ou plus avec:
- Anti H2, AINS, Digoxine, fluoroquinolones, Corticoïdes, IPP,

Indications

- Traitement symptomatique des douleurs des affections oeso-gastro-duodénales.

II - Les antiémétiques

A - Les Antiémétiques et antireflux

Spécialité

Dompéridone **MOTILUM[®], DOMPERIDONE[®]**
Métoclopramine **PRIMPERAN[®] METOCLOPRAMINE[®]**
Présentation: cp., orodispersible, susp. Buv. Amp inj.

Propriétés

Antiémétique puissant sans effet anticholinergique

Contre-Indications

Dyskinésies tardives dues aux neuroleptiques, hémorragie, obstruction ou perforation gastro-intestinal

Effets indésirables

Rares ou exceptionnels (surtout pour Dompéridone qui est préférée)
Dompéridone: troubles extrapyramidaux
Métoclopramine: troubles extrapyramidaux, troubles endocriniens

Précautions d'emploi

Réduire la posologie chez les insuffisants rénaux sévères

Interactions médicamenteuses

Les anticholinergiques
Avec métoclopramine: interaction avec la Lévodopa

Indications

Nausées et vomissements
Manifestations dyspeptiques liées à un trouble de la motricité digestive

II

B - Autres Antiémétiques

Spécialité

Métopimazine **VOGALENE[®]** Présentation: Lyoc. Gouttes. Buv. , Amp inj.

Propriétés

Antiémétique puissant avec des propriétés neuroleptiques et anticholinergiques

Contre-Indications

Risque de glaucome par fermeture de l'angle et de rétention urinaire

Effets indésirables

Rares ou exceptionnels (surtout à forte dose): bouche sèche, somnolence, constipation, troubles extrapyramidaux

II

B - Autres Antiémétiques

Spécialité

Métopimazine **VOGALENE®** Présentation: Lyoc, Gouttes, Buv., Amp inj.

Propriétés

Antiémétique puissant avec des propriétés neuroleptiques et anticholinergiques

Contre-Indications

Risque de glaucome par fermeture de l'angle et de rétention urinaire

Effets indésirables

Rares ou exceptionnels (surtout à forte dose): bouche sèche, somnolence, constipation, troubles extrapyramidaux

Précautions d'emploi

Réduire la posologie chez les insuffisants rénaux sévères

Interactions médicamenteuses

Les anticholinergiques, Lévodopa et agonistes dopaminergiques

Indications

Nausées et vomissements

II

C - Les antiémétiques: Sétrons

Spécialité

Dolasetron **ANZEMET®**

Granisetron **KYTRIL®**

Ondansétron **ZOPHREN® ONDANSETRON® Ge**

Présentation: cp, Lyoc, Suppos., Amp inj. Suffixe SETRON

Propriétés

Antiémétiques puissants antagonistes des récepteurs 5 HT₃ sans effets extra-pyramidaux

Contre-Indications

Hypersensibilité connue à l'un des constituants

Effets indésirables

Céphalées modérées, constipation, sensation de chaleur.

Précautions d'emploi

Grossesse et allaitement innocuité non établie

Interactions médicamenteuses

Associations utiles : corticoïdes effet antiémétique accru, Paracétamol (céphalées)

Compatibles avec solutés salés et glucosés isotoniques, Mannitol 10% et Ringer.

Indications

Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par les chimiothérapies et les radiothérapies cytotoxiques émétisantes et en préventif en post opératoire.

II

D - Les antiémétiques: Antagoniste des récepteurs NK1 de la substance P

Spécialité

Aprécipitant **EMEND®**

Présentation: gélule

Propriétés

la substance P joue un rôle dans les vomissements

Contre-Indications

Hypersensibilité connue à l'un des constituants et interactions médicamenteuses

Effets indésirables

Précautions d'emploi

Grossesse et allaitement innocuité non établie

Interactions médicamenteuses ++++

Associations contre-indiquées: médicament entraînant des torsades de pointes, inducteurs enzymatiques puissant CYP 3A4 (rifampicine, carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne, ...).

Associations à utiliser avec précautions: inducteurs et inhibiteurs de la CYP 3A4 CYP P2C9

Indications

Prévention des nausées et vomissements induits par les chimiothérapies hautement et moyennement émétisantes dont le cisplatine.

II

E - Antinaupathiques ou médicaments du mal des transports

Spécialités et Propriétés

Anticholinergiques **SCOPODERM TTS®**

AntiHistaminiques H1 : **MERCALM®, NAUSICALM®**

Homéopathie **COCCULINE®**

Contre-Indications

Risque de glaucome par fermeture de l'angle et de rétention urinaire, grossesse sauf Scopoderm
allaitement, enfant <2 ans

Sauf cocculine® pas de CI

Effets indésirables

+++

Sauf cocculine® pas d'EI

Interactions médicamenteuses

+++

Sauf cocculine® pas d'IM

Indications

Nausées et vomissements du mal des transports

A - Réhydratation orale

Spécialités

Solution de réhydratation orale	ADIARIL°, GES 45°, VIATOL°
Réhydratation orale en situation isolée	Coca Cola° modifié

Propriétés et indications

Traitement essentiel de toute diarrhée aiguë quel que soit son mécanisme

Contre-Indications

Déshydratation sévère (perte de poids supérieur à 10 %) et ou vomissements incoercibles
et ou signe de gravité comme choc, hypovolémie

Posologie

Quantité à adapter en fonction de la perte de poids

III

B - Les ralentisseurs du transit

Spécialité

Lopéramide: **LOPERAMIDE°, IMODIUM°**
Présentation: gélule, lyocs, solution buvable

Propriétés

Antidiarrhéique opiacé

Contre-Indications

Enfants de moins de 2 ans (solution) antécédent d'allergie au produit, poussée de rectocolite hémorragique

Effets Indésirables

Constipation, rashs cutanés
Surdosage: risque d'ileus paralytique

Précautions d'emploi et interactions médicamenteuses

Produits ne dispensant pas d'une réhydratation hydrosodée
Utilisation avec prudence en cas d'insuffisance hépatique ou d'adénome prostatique
IM: laxatifs de lest

Indications

Traitement symptomatique des diarrhées

III

C - Les antisécrétoires intestinaux

Spécialité

Racécadotril **TIORFAN®**

Présentation: gélule, sachet

Propriétés

Antisécrétoires intestinaux diminution des hypersécrétions dues à la toxine cholérique et l'inflammation sans altération du transit

Contre-Indications

Grossesse et allaitement - Intolérance au produit

Effets Indésirables

Rare cas de somnolence

Précautions d 'emploi et interactions médicamenteuses

Produit ne dispensant pas d'une réhydratation hydrosodée

Insuffisance hépatique et rénale: pas de données

Grossesse et allaitement: ne pas utiliser

Indications

Traitement symptomatique des diarrhées aiguës

III

D - Les produits d'origine biologique

Spécialité

ULTRA LEVURE®, BACICLOR®, LACTEOL FORT®

Présentation: gélule, sachet

Propriétés

Flores levuriques ou bactériennes

Contre-Indications

Intolérance au lactose

Précautions d 'emploi et interactions médicamenteuses

Produits ne dispensant pas d'une réhydratation hydrosodée

Indications

prévention des diarrhées non organique et induite par antibiothérapie

ACTION NON DEMONTREE

III

E - Les absorbants antidiarrhéiques

Spécialité

SACOLENE®

Présentation: poudre, sachet

Propriétés

Adsorbant antidiarrhéique hydrophile

Contre-Indications

Sacolène: allergie à un constituant, intolérance au fructose,...

Précautions d'emploi et interactions médicamenteuses

Produit ne dispensant pas d'une réhydratation hydrosodée

Indications

Traitement des diarrhées

Remarques:

Les silicates comme BEDELIX®, ACTAPULGITE®, SMECTA® sont utilisés dans les traitements symptomatiques des colopathies fonctionnelles en particulier avec météorisme et des diarrhées (SMECTA®).

IV - Les Laxatifs

A - Les laxatifs osmotiques hypoammoniémiants ou acidifiants coliques

Spécialités

DUPHALAC®, LACTULOSE®, IMPORTAL®

Propriétés

Disaccharides de synthèse réduisant l'absorption intestinale de l'ammoniac par
stimulant le péristaltisme intestinal

24/38

1 c



Contre-Indications

Régime exempt de galactose et colopathie inflammatoire, subocclusion et occlusion

Effets indésirables et interactions médicamenteuses

Météorisme transitoire, prurit

Surdosage : Diarrhée

Indications

Traitement de la constipation même chez la femme enceinte et le nourrisson

IV

B - Autres laxatifs osmotiques

Spécialité

FORLAX[®], MOVICOL[®], TRANSipeg[®], SORBITOL[®]

Propriétés

Laxatif osmotique agissant en 24 à 48h00 par réhydratation du bol ou action cholagogue

Contre-Indications

Colopathie inflammatoire syndrome occlusif ou sub occlusif

Syndromes douloureux abdominaux d'étiologie indéterminée

Régime exempt de galactose et colopathie inflammatoire, sub occlusion et occlusion

Effets indésirables et interactions médicamenteuses

Diarrhée et douleurs abdominales à fortes doses

IM: Kayexalate avec le sorbitol

Indications

Traitement de la constipation

IV

C - Les laxatifs de lests - Mucilages

Spécialité NORMACOL[®], TRANSILANE[®], SPAGULAX[®]

Propriétés

Polysaccharides non digestes à pouvoir hygroscopique délai : quelques jours; hydratation du bol

Contre-Indications Affections sténosantes du tube digestif, enfant < 2 ans, allergie au produit,...

Effets indésirables et interactions médicamenteuses

Ballonnement intestinal en début de traitement, réactions allergiques

IM: Lopéramide et ralentisseur du transit

Indication Traitement de la constipation

D - Les laxatifs de lests – Fibres alimentaires

Spécialité ACTISON[®], ALLBRAN[®], CELLUSON[®]

Propriétés

Fibres alimentaires contenues dans le son les céréales et agit en quelques jours par augmentation du bol alimentaire

Contre-Indications Syndrome occlusif sub occlusif, fécalome enfant < 8 ans,...

Effets indésirables et interactions médicamenteuses

Ballonnement intestinal en début de traitement et douleurs abdominales

Indication Traitement de la constipation

IV

E - Les laxatifs lubrifiants

Spécialité Huile de paraffine LUBENTYL[®], LANSOYL[®]

Propriétés

Laxatif mécanique en lubrifiant le colon et en ramollissant les selles

Effets indésirables et interactions médicamenteuses

Suintement anal fréquent

Apprendre 2 h00 avant de se coucher: éviter inhalation Diarrhées et douleurs abdominales à fortes doses

IM: Diminution de l'absorption des vitamines liposolubles (A D E K)

Indication Traitement de la constipation

F - Les laxatifs par voie rectal

Spécialité EDUCTYL® MICROLAX® RECTOPANBILINE®

Propriétés Agissent en provoquant le réflexe de défécation 5 à 20 minutes

Contres-indications

Lésions locales comme hémorroïdes

Effets indésirables

Risque de rectites en cas d'action prolongée

Indication Traitement de la constipation basse

IV

G - Les laxatifs stimulants

Spécialité

Bisacodyl

CONTALAX®

Laxatifs anthracéniques

MODANE® TAMARINE®

Laxatifs salins

LUBENTYL® MAGNESIE®

Propriétés

Ceux sont des laxatifs stimulants augmentent la motricité colique et la sécrétion intestinale d'eau d'électrolytes et de protéines

Contre-indications

Grossesse, allaitement, enfant de moins de 15 ans colopathie inflammatoire, etc.

Effets indésirables et interactions médicamenteuses

Assez fréquent douleurs abdominales et diarrhée

En usage prolongé état de dépendance rendant difficile le sevrage difficile

Précaution d'emploi

Pas d'utilisation prolongée (8 à 10 jours maximum)

Interactions médicamenteuses

Médicament provoquant des torsades de pointes

Indications

Traitement de courte durée des constipations occasionnelles

V - Les extraits pancréatiques

Spécialité

Enzymes pancréatiques CREON® EUROBIOL® LICREASE®

Présentation: gélule, sachet

Propriétés

Enzymes pancréatiques à titre substitutif nécessaires à la digestion (lipases, protéases, amylases)

Contre-Indications

Pas de CI

Indications

Insuffisance pancréatique exocrine de l'adulte et de l'enfant notamment au cours des pancréatites chroniques et de la mucoviscidose.

VI - Les médicaments utilisés dans la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn

A - Les corticoïdes par voie rectale

Spécialité

Lavements cortisoniques

BETNESOL®

Mousses rectales cortisoniques

COLOFOAM®

Propriétés

Corticostéroïdes ayant une action antiinflammatoire intense sur la muqueuse intestinale et remarquable efficacité sur les poussées de rectocolite aiguë

Contre-indications

Générales : ulcères gastro-duodénaux évolutifs, états infectieux ou mycosiques non contrôlés, viroses évolutives

Local: Abscès perforations, fistules extensives, obstruction intestinale.

Effets indésirables et interactions médicamenteuses

Possibilités de résorption digestive avec signes d'hypercorticisme en cas de traitement prolongé à forte dose

Risque de surinfection locale

Précautions d'emploi

Risque de perforation intestinale

Utiliser avec prudence en cas de troubles hydro-électrolytiques, de fuite calcique, de catabolisme protéique intense et chez la femme enceinte

Indications

Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn

VI

B - Acide 5-aminosalicylique

Spécialité

PENTASA®, ROWASA®, FIVASA®

Voie orale et rectale

Propriétés

Agit au niveau colique par des mécanismes multiples et mal élucidés (action immunosuppressive, antiinflammatoire et sur la synthèse des prostaglandines)

Contre-indications

Hypersensibilité à l'aspirine ou aux salicylés

Grossesse et allaitement (innocuité non démontré)

Effets indésirables (deux fois moins fréquent qu'avec la sulfasalazine)

Céphalées, nausées, vomissements

Diarrhées

Exceptionnels: néphropathie, atteinte hématologique

Précautions d'emploi

Utiliser avec précaution en cas insuffisance rénale ou hépatique

Surveiller la fonction rénale, la NFS, les enzymes hépatiques

Indications

Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn en poussées évolutives et traitement d'entretien

VI

C - La Sulfasalazine

Spécialité

SALAZOPYRINE °

Voie orale

Propriétés

Agit au niveau colique par des mécanismes multiples et mal élucidés (action immunosuppressive, antiinflammatoire et sur la synthèse des prostaglandines)

Moins bonne tolérance que 5-ASA

Contre-indications

Hypersensibilité à l'aspirine ou salicylés

Grossesse et allaitement (innocuité non démontrée)

Effets indésirables (deux fois plus fréquent avec le 5 ASA)

Dose dépendant anorexie, nausées, vomissements

Réactions allergiques

Atteintes hématologiques

Précautions d'emploi

Réduire posologie en cas insuffisance rénale ou hépatique

Surveillance biologique nécessaire

Indications

Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn en poussées évolutives et traitement d'entretien

Préférer le 5-ASA

VI

D - Inhibiteurs du TNF-alpha

Spécialité

Infliximab **REMICADE °**

Voie injectable - A conserver entre + 2 et +8°C - Médicament onéreux hospitalier

Propriétés

Anticorps monoclonal murin - humain dirigé contre le facteur alpha de nécrose tumorale

Élimination lente (3 mois en moyenne)

Contre-indications

Hypersensibilité au produit tuberculose, infection aiguë ou chronique, grossesse et allaitement

Effets indésirables

Réaction d'hypersensibilité 25% - arrêt définitif si réactions graves (< 1%)

Fréquents: infections virales, fièvre, céphalées, vertiges,

Peu fréquent: abcès, syndrome lupique,

Précautions d'emploi

Administrer sous surveillance médicale spécialisée

avec possibilité de traitement immédiat des réactions anaphylactiques

Indication

Maladie de Crohn (recours après échec des corticoides et l'azathioprine)

VII - Les pansements digestifs

A - Les antireflux

Spécialité

Alginate + Bicarbonate de sodium

GAVISCON °

Alginate + Hydroxydes d'aluminium

TOPAAL °

Propriétés

Alginates forment un gel surnageant à la surface du contenu gastrique avec une effet de barrière physiologique

Contre-indications

	Alginates forment un gel surnageant à la surface du contenu gastrique avec une effet de barrière phys
Contre-indications	Aucune
Remarque	Surélever la tête du lit, supprimer les stimulants de la sécrétion gastrique (alcool, vinaigre, ...)
Interactions	Hydroxydes d'aluminium possibilité de déplétion phosphorée Respecter un intervalle de 2 h00 entre les prises orales
Indication	Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien

VII

B - Le charbon

Spécialité	CARBOLEVURE°, CARBOSYLANE°, CHARBON DE BELLOC°
Propriétés:	Adsorbant des gaz , liquides et toxines par action physique
Effets indésirables	Constipation à forte dose
Interactions médicamenteuses	Produit capable d'adsorber un très grand nombre de médicaments Respecter un intervalle de 2 h00 entre les prises orales
Indications	Traitement symptomatique des états dyspeptiques et météorismes

VIII - Le traitement antihémorroïdaire

A - Les veinotoniques et vasculoprotecteurs

Spécialités	Vitamine P ou Flavonoïdes: ESBERIVEN FORT°, VEINAMITOL°, DIOSMINE°, DAFLON°, C <u>Présentation</u> : gélule, ampoule, sachet
Propriétés	Agit en augmentant le tonus veineux et la résistance capillaire et en diminuant la perméabilité capillai Effet thérapeutique n'est pas rigoureusement établi
Contre-indications	Intolérance aux constituants dont diarrhée ou hépatite
Effets indésirables et Précautions d'emploi	Possibilité de diarrhée chronique parfois sévère et d'hépatite : arrêt immédiat et définitif du traiteme Suppression des facteurs déclenchants (constipation , alcool, épices), incision, sclérose ou traitement

Intolérance aux constituants dont diarrhée ou hépatite

Effets indésirables et Précautions d'emploi

Possibilité de diarrhée chronique parfois sévère et d'hépatite : arrêt immédiat et définitif du traitement
Suppression des facteurs déclenchants (constipation, alcool, épices), incision, sclérose ou traitement

Indication

Traitement des hémorroïdes, dont poussée aiguë posologie : dose maximales indiquées

VIII

B - Les antihémorroïdaires locaux ou topiques antihémorroïdaires

Spécialité

DELIPROCT[®], ULTRAPROCT[®], PROCTOLOG[®]

Présentation : suppositoires et crème

Propriétés

Association de produits à action anti-inflammatoire (corticoïde), antalgique, antiprurigineuse (anesthésiques) et veinotonique (esculoside, ruscogénines)

Contre-indications

Allergie aux constituants

Précautions d'emploi

Suppression des facteurs déclenchants (constipation, alcool, épices)
Associé à un traitement antibactérien adapté et ou antifongique en cas de lésion surinfectée

Indications

Traitement des hémorroïdes, dont poussée aiguë

VIII

C - Les sclérosants hémorroïdaires

Spécialité

KINUREA H[®] Présentation : ampoule

Propriétés

sclérose

Contre-indications

Intolérance, névrites optiques et grossesse

Effets indésirables

Rares
Douleurs lors de l'injection, douleurs rectales, rectorragies minimes

Précaution d'emploi

Nécessite une compétence technique spécialisée

Posologie

4 à 6 injections à raison d'une par semaine (intervalle de 4 jours minimum entre les injections)

Indications

Sclérose des hémorroïdes